



VERSÃO PRELIMINAR

MANUAL PARA INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO

LIBERADOR DE ETONOGESTREL 68MG



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





VERSÃO PRELIMINAR

MANUAL PARA INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO

LIBERADOR DE ETONOGESTREL 68MG



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



© 2025 Ministério da Saúde.



Alguns direitos reservados. É permitida a reprodução, divulgação e distribuição e utilização dessa obra, em parte ou em sua totalidade, nos termos da licença para usuário final do Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES). Deve ser citada a fonte e é vedada a sua utilização comercial

Elaboração, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Gestão do Cuidado Integral
Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher
Esplanada dos Ministérios - Bloco O, 8º andar
CEP: 70050-000 – Brasília/DF
Site: <https://aps.saude.gov.br>
E-mail: saps@saude.gov.br

Organização, coordenação e supervisão geral:

José Eudes Barroso Vieira – Desco/Saps/MS
Olivia Lucena de Medeiros – DCGI/Saps/MS

Coordenação técnica geral:

Ana Cláudia Cardozo Chaves – Cgesco/Desco/Saps/MS
Mariana Seabra Souza Pereira – Cgesmu/DGCI/Saps/MS
Sonia Ioyama Venancio – CGCRIA/DGCI/Saps/MS

Elaboração, revisão e atualização de texto:

Brunely da Silva Galvão
Camila Emanoela de Lima Farias
Carolina Sales Vieira
Hortência Hellen de Azevedo Medeiros
Jessica Rodrigues Machado
Layza Nogueira Dias Dos Santos
Luciana Mara Silva Almeida
Luciane da Silva d'Ávila
Suelen Alves Rocha

Apoio:

Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade
(Abefaco)
Associação Brasileira de Obstetras e Enfermeiras Obstétricas
Abenfo Nacional
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)

Coordenação editorial:

Julia César de Carvalho e Silva

Projeto gráfico e diagramação:

Daniel Miranda Costa
Lucas Bucar

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
xxxxxxxxx18 p. : il.

Modo de acesso: World Wide Web: xxxxxx ISBN: xxxxx

1. Atenção Primária à Saúde. 2. Projeto de Lei. I. Título.

xxxxxx

Título para indexação:
xxxxxx

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Justificativa	5
3. Objetivo	5
4. Tecnologia	5
5. Critérios de elegibilidade	6
6. Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	8
7. Inserção do implante	9
8. Registro do procedimento	14
9. Retornos clínicos	19
10. Retirada do implante	23
11. Troca do implante	25
Referências bibliográficas	30

1. APRESENTAÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha papel central no acompanhamento integral da população, constituindo-se como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e o espaço de vínculo contínuo ao longo do curso de vida. No campo da saúde da mulher, destaca-se pela capacidade de articular ações de promoção, prevenção, recuperação e cuidado, com ênfase na saúde sexual e saúde reprodutiva.

Como parte dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, o planejamento familiar é uma prerrogativa assegurada pela Constituição, além de integrar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM). A APS favorece o planejamento reprodutivo, o aconselhamento qualificado e o acompanhamento longitudinal, fortalecendo a autonomia e a tomada de decisões conscientes sobre seus projetos de vida. Ao alinhar-se às necessidades do território e às singularidades de cada fase, a APS reafirma sua potência como ordenadora do cuidado e espaço estratégico para a oferta de métodos contraceptivos, entre eles, o implante subdérmico liberador de etonogestrel, inserido como parte das estratégias de cuidado integral em saúde sexual e saúde reprodutiva no âmbito do SUS.

A Lei Nº. 9.263 de 12 de janeiro de 1996 regulamenta o §7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar, e determina que, para o seu exercício, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitas, que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. Os métodos contraceptivos fornecidos pelo SUS incluem: preservativos interno e externo; métodos reversíveis, como anticoncepcionais orais combinados (estrogênio e progestagênio), pílula de progestagênio (minipílula), injeções contraceptivas mensais e trimestrais; métodos reversíveis de longa duração, como o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre; e métodos irreversíveis ou cirúrgicos, como laqueadura tubária bilateral e vasectomia.

A incorporação do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel se deu por meio da Portaria SECTICS/MS Nº. 47, de 8 de julho de 2025 e Portaria SECTICS/MS Nº. 48, de 8 de julho de 2025, abrangendo mulheres de 14 a 49 anos. Sendo um método contraceptivo reversível de longa duração (LARC – Long Acting Reversible Contraceptives, em inglês), o implante subdérmico oferece como principais vantagens: alta eficácia (menor índice de Pearl entre todos os métodos contraceptivos); poucas contraindicações; e possibilidade de redução da dismenorreia, da frequência e do número de dias de sangramento. Atualmente, o implante subdérmico contraceptivo disponível no país apresenta duração de três anos, com liberação de etonogestrel.

A principal causa de remoção prematura do implante é o sangramento uterino desfavorável (em geral o sangramento frequente e/ou o prolongado), especialmente quando acompanhado de orientação inadequada sobre as mudanças esperadas da menstruação. A inserção e a remoção do implante de etonogestrel são considerados procedimentos simples, que levam poucos minutos, embora necessite de local próprio e profissional devidamente treinado, seja enfermeiro(a) (Parecer do Conselho Federal de Enfermagem Nº. 277/2017) ou médico(a), em qualquer nível de atenção que o profissional atue.

A oferta do implante subdérmico de etonogestrel no âmbito do SUS ocorrerá prioritariamente na APS, em especial pelas equipes de Saúde da Família e demais equipes que atuam nesse nível de atenção, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Essa estratégia reforça a centralidade da APS na coordenação do cuidado e na promoção da integralidade, assegurando o acompanhamento longitudinal das usuárias, articulação com as demais ações de saúde sexual e reprodutiva, e a garantia do direito ao acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes.

Neste contexto, considerando que compete ao Ministério da Saúde (MS) desenvolver estratégias e mecanismos organizacionais voltados à qualificação e à valorização da força de trabalho em saúde no âmbito do SUS, com ênfase na formação e na educação permanente, para a promoção da saúde e a efetivação das políticas nacionais, a área técnica de Saúde da Mulher do MS elaborou a presente orientação, destinada a apoiar os profissionais na inserção do implante subdérmico no contexto do Planejamento Familiar e Reprodutivo.

2. JUSTIFICATIVA

Entre os países em desenvolvimento, 84% das gravidezes não planejadas são decorrentes de demandas contraceptivas não atendidas (DARROCH et al, 2017). Estima-se que cerca de metade das mulheres e pessoas com capacidade de gestar que vivem nesses países desejam evitar uma gravidez, entretanto, aproximadamente 25% não têm acesso a métodos modernos de contracepção. Apesar da crescente melhora na oferta de métodos contraceptivos, e com proporções menores de demandas não atendidas no tema desde 2014, esses países ainda enfrentam o desafio do aumento de mulheres em idade reprodutiva (DARROCH et al, 2017).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, 80,5% das mulheres e outras pessoas com capacidade de gestar no Brasil estavam em uso de algum método contraceptivo. Entre aquelas em uso destes, 22,9% usavam algum método de esterilização (irreversível), sendo 17,3% a laqueadura; 4,4% usavam o DIU; 9,8% usavam métodos hormonais injetáveis; 40,6% usavam anticoncepcional oral (pílula); 20,4% usavam o preservativo externo; 0,6% usavam algum outro método moderno (preservativo interno, anel, adesivo) e 1,2% algum método tradicional (tabelinha, coito interrompido).

Ainda assim, no Brasil, as gestações não intencionais seguem a mesma tendência dos demais países em desenvolvimento. Entre os anos de 2021 e 2023, conforme a pesquisa “Nascer no Brasil II” (2021-2023 apud Silva, 2025), cerca de 33% a 40% das gestantes avaliadas não haviam planejado aquela gravidez. O número de partos, no Brasil, em 2023, em meninas de 15 a 19 anos foi de 289.093, ou seja, 11,39% do total (BRASIL, 2025). As regiões norte e nordeste seguem, desde 2013, com os índices mais elevados de nascidos vivos entre mães adolescentes, impactando notadamente meninas e mulheres negras (pretas e pardas), que respondem por mais de 70% das gestações nessa fase da vida (SINASC).

Ampliar a oferta de métodos contraceptivos e promover o acesso nas unidades da APS tem o potencial de contribuir significativamente para a redução das gravidezes não intencionais e, por consequência, impactar positivamente na mortalidade materna (FIOCRUZ, 2024). Atualmente, as principais causas de mortalidade materna no território brasileiro são: doenças hipertensivas gestacionais; hemorragia pós-parto; infecções puerperais e complicações decorrentes de abortos induzidos (BRASIL, 2021).

Quando se observa a taxa de continuidade do uso dos implantes subdérmicos no primeiro ano, variam de 57 a 97%, a depender da orientação pré-inserção (MORAY et al, 2021). O DIU de cobre, por sua vez, tem uma taxa de continuidade de 78% no primeiro ano. Em ambos os casos, há altas taxas de eficácia (índice de falha inferior a 1%) e a vantagem da reversibilidade quando comparados aos métodos cirúrgicos (TRUSSEL, 2011; HARVEY et al, 2009; MODESTO et al, 2014; TEUNISSEN, et al, 2014).

3. OBJETIVO

Fornecer subsídios aos profissionais de saúde médicos(as) e enfermeiros(as) para a inserção, retirada e o manejo do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel.

4. TECNOLOGIA

O implante subdérmico liberador de etonogestrel consiste em um pequeno bastão de plástico

(etileno vinil acetato), com 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro que contém 68 mg da substância etonogestrel. O etonogestrel é um progestagênio (hormônio) sintético. A ação do implante ocorre a partir da liberação de uma pequena quantidade de etonogestrel continuamente na corrente sanguínea, a qual impede a ovulação, além de espessar a secreção do colo do útero, dificultando a entrada de espermatozoides no útero. O implante pode permanecer no corpo (inserido abaixo da pele do braço) por um período de até três anos, conforme recomendações atuais descritas na bula.

A eficácia do implante de etonogestrel não depende da adesão da paciente, contribuindo para a menor taxa de falha entre os contraceptivos disponíveis atualmente; cerca de 0,05%. Tanto a inserção quanto a retirada do dispositivo são procedimentos ambulatoriais e devem ser realizados por profissionais de saúde treinados. Não são necessários exames complementares para a realização da inserção ou retirada do implante, salvo em implantes não palpáveis que provêm de inserções profundas que são incomuns (< 3 casos /1000 inserções) (REED et al, 2019; SIUM et al, 2025).

O implante pode ser utilizado como anticoncepção imediata pós-evento obstétrico (AIPEO), incluindo parto, dado que não interfere na amamentação ou crescimento do recém-nascido (BRITO et al, 2019; BRAGA et al, 2015; CARMO et al, 2017; DE NADAI et al, 2025). Após a remoção do implante, não há atraso no retorno à fertilidade (GLASIER, 2002).

Entre os principais efeitos secundários positivos do método estão: a redução de cólicas, redução da frequência e número de dias da menstruação, e redução da dor pélvica associada à endometriose (CARVALHO et al, 2018; MANSOUR et al, 2008). Os principais efeitos negativos, relatados por usuárias, envolvem sangramento não previsível e prolongado, tontura, acne e cefaléia (DARNEY et al, 2009; BAHAMONDES et al, 2015). Não há impactos negativos na densidade óssea ou aumento do risco de neoplasia de mama, ovário ou eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico (MORAY, 2021).

Assim como os demais contraceptivos de progestagênio isolado, o implante de etonogestrel provoca alterações no sangramento menstrual. A maior parte das usuárias ficarão satisfeitas com as mudanças, já que a maioria das usuárias apresentam menos episódios de sangramento com este contraceptivo. De uma forma geral, 80% das usuárias do implante vão evoluir, em até 12 meses após a inserção, com redução do número de episódios sangramentos, ou seja, vão sangrar uma vez por mês ou menos, podendo inclusive não apresentar sangramento durante o uso deste método. Já 20% das usuárias apresentam sangramentos frequentes, ou seja, mais de uma vez por mês, ou prolongados (com duração de 14 dias por mês ou mais) (MANSOUR et al, 2008; MANSOUR et al, 2019).

5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

5.3 - Quando iniciar o método

O implante subdérmico pode ser inserido a qualquer momento, desde que haja razoável certeza de que não há gravidez em curso, observando-se as seguintes condições (TEPPER et al, 2013):

- Até o sétimo dia do ciclo menstrual;
- Ausência de relação sexual desprotegida no mês prévio à inserção, com menstruação regular;
- Uso prévio consistente e correto de qualquer método contraceptivo confiável;
- Imediatamente pós-parto ou pós-aborto;

- Nos sete (7) primeiros dias após o aborto;
- Até quatro semanas após o parto, independente da amamentação;
- Entre quatro (4) semanas e seis (6) meses após o parto desde que a usuária esteja em amamentação exclusiva e em amenorreia.

Quando não houver certeza razoável de ausência de gravidez, recomenda-se a realização do teste rápido de gravidez (teste imunológico de gravidez urinário).

A solicitação de ultrassonografia transvaginal, citologia de colo uterino e qualquer outro exame complementar não deve condicionar ou atrasar o acesso ao método contraceptivo.

5.4 - Contraindicações ao método

O método não pode ser usado nas seguintes condições clínicas (OMS, 2015):

5.4.1 - Contraindicação absoluta (categoria 4):

- Câncer de mama atual e demais neoplasias sensíveis a esteroides sexuais. O histórico familiar não contraindica.
- Gravidez.

5.4.2 - Contraindicações relativas (categoria 3):

- Sangramento genital irregular não investigado (quando não for possível afastar uma gestação);
- Tromboembolismo venoso agudo na ausência de anticoagulação;
- Infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral em vigência de uso do método (o histórico destas condições é classificado como categoria 2);
- Enxaqueca com aura durante o uso do método (se for prévia, não há contraindicação);
- Adenoma hepatocelular, adenocarcinoma hepatocelular, cirrose hepática severa;
- Câncer de mama tratado há mais de cinco (5) anos;
- Lúpus eritematoso sistêmico com positividade para anticorpos antifosfolípidos;
- Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer outro componente do implante subdérmico.

Tabela 1: Critérios de elegibilidade para uso do implante subdérmico contraceptivo.

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

Categoria 2: O método pode ser usado. Benefícios superam riscos.

Categoria 3: O método não deve ser usado. Caso seja usado, deve ser o método de última escolha, com acompanhamento rigoroso.

Categoria 4: O método não deve ser usado. Risco inaceitável.

CONDIÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE	CATEGORIA PARA USO DO IMPLANTE
48 horas a 4 semanas pós-parto	2
Imediato pós-aborto	1
Neoplasia trofoblástica gestacional	1
LES com anticorpo antifosfolípide positivo	3
TEV agudo sem uso de anticoagulação	3
IAM, AVC e enxaqueca com aura durante uso do método	3
Histórico de IAM, AVC ou TEV	2
Adenoma hepatocelular, adenocarcinoma hepatocelular, cirrose hepática severa	3
Hepatite viral aguda	1
Sangramento vaginal inexplicado quando não é possível afastar gestação	3
Mioma com distorção da cavidade uterina, anormalidades anatômicas, DIP atual, TB pélvica	1
Câncer de colo	2
Câncer de mama atual	4
Câncer de endométrio	1
Câncer de mama sem evidências de doença ativa por 5 anos	3

CATEGORIAS



World Health Organization (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva: WHO; 2015.

NTG: neoplasia trofoblástica gestacional; BHCG: gonadotrofina coriônica humana; LES: lúpus eritematoso sistêmico; AVC: acidente vascular cerebral; IAM: infarto agudo do miocárdio; TEV: tromboembolismo venoso; DIP: doença inflamatória pélvica; TB: tuberculose.

Nos casos em que não haja elegibilidade ao método, o profissional deve orientar método contraceptivo alternativo disponível.

6. LEITURA E ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O termo de consentimento está disponível no Anexo I deste documento. Sempre que houver interesse da pessoa elegível no uso do método, deve-se realizar a avaliação clínica quanto às contraindicações e proceder à leitura e à assinatura do Termo em conjunto com a pessoa, considerando a adaptabilidade da linguagem conforme o contexto cultural vivenciado. Todas as dúvidas devem ser esclarecidas para que a pessoa compreenda os efeitos adversos e efeitos secundários esperados com uso do método, tendo assegurada a retirada a qualquer momento mediante seu desejo.

Ademais, deve-se garantir o atendimento de adolescentes nos serviços de saúde, mesmo quando desacompanhados por seus responsáveis legais ou acompanhados por pessoa de sua escolha.

Ter um acompanhante nos atendimentos de saúde é um direito, contudo não constitui uma impressibilidade, primando-se pela garantia da privacidade e sigilo, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas diretrizes do Ministério da Saúde. Ressalta-se ainda a não obrigatoriedade da autorização verbal ou escrita dos responsáveis pelo adolescente para a inserção do implante subdérmico ou prescrição de qualquer outro método contraceptivo. (BRASIL, 2021; BRASIL, 2022).

O sigilo e a confidencialidade permanecem obrigatórios no caso de informações compartilhadas pelas(os) adolescentes durante o atendimento, exceto em situações de risco à vida ou à integridade física ou psicológica da(o) adolescente e/ou de terceiros, quando a quebra do sigilo se faz necessária para a sua proteção. Neste caso, profissionais de saúde devem saber em quais situações a quebra do sigilo é justificada e sobre os procedimentos éticos e legais para a sua realização (BRASIL, 2021).

7. INSERÇÃO DO IMPLANTE

Antes da realização do procedimento, é importante retomar a orientação utilizando metodologia ativa, confirmando a compreensão da pessoa sobre os riscos, benefícios, possíveis reações adversas e secundárias, tempo de duração do método e garantia de remoção. Deve-se também reforçar que as modificações desfavoráveis da menstruação (aumento da frequência e duração) são mais comuns nos primeiros três meses, reduzindo com o tempo de uso do implante, entre 6 a 12 meses, sendo esse fenômeno esperado e não indicativo de ineficácia do método.

A técnica de inserção do implante deve seguir as seguintes etapas, ilustradas pelas imagens abaixo:

- Realizar a organização do material necessário para a inserção:
- Luvas de procedimento;
- Antisséptico (clorexidina alcoólica 0,5%, álcool 70% ou iodopovidona tópico 10%);
- Gaze estéril;
- Seringa de 3ml;
- Agulha para aspiração 40x12mm;
- Agulha para injeção 13x4.5mm;
- Lidocaína 1% ou 2%, sem vasoconstritor;
- Esparadrapo e/ou atadura;
- Implante subdérmico.
- Realizar a identificação da pessoa em que será inserido o dispositivo de maneira ativa com ao menos dois identificadores (nome completo e data de nascimento);
- Posicionar o braço da pessoa flexionado na altura do cotovelo, com a mão sob a cabeça (ou o mais próximo possível dela), dando preferência ao braço não dominante. Realizar avaliação visual do local identificando lesões prévias, processos infecciosos ou outras alterações anatômicas relevantes;

Figura 1: Posicionamento do braço.

- Posicionar-se de forma que seja possível visualizar a progressão da agulha logo abaixo da pele (olhando lateralmente e não por cima do aplicador), prevenindo inserções profundas;
- Identificar o local de inserção na face medial do braço não dominante;
- Medir 8 a 10 cm a partir do epicôndilo medial do úmero, e 3 a 5 cm abaixo do sulco entre os músculos bíceps e tríceps;
- Se não for possível estabelecer a distância de 3 a 5 cm (por exemplo, em paciente com braços finos), o implante deve ser inserido o mais distante possível do sulco, evitando vasos sanguíneos e os nervos maiores que existem no sulco e na região próxima;
- Realizar a primeira marcação do local de inserção;

**Figura 2: Identificação do local de inserção, utilizando fita métrica.****Figura 3: Identificação do local de inserção, utilizando as mãos.**

Figura 4: Identificação de marcos anatômicos.

- Realizar uma segunda marcação, aproximadamente 5cm da primeira marcação (marca guia);

Figura 5: Pontos de orientação para inserção.

- Explicar novamente à pessoa o procedimento a ser realizado;
- Verificar a validade do implante;
- Retirar o invólucro externo (caixa);
- Conferir a integridade do invólucro interno;
- Separar bula e cartão do paciente para posterior preenchimento;
- Lavar as mãos;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Limpar o local de inserção com um antisséptico;
- Aplicar anestesia local utilizando lidocaína 1% ou 2%, sem vasoconstritor, em quantidade suficiente para anestesiá-la toda a região, onde o implante será inserido (aproximadamente 4 cm). A dose recomendada é de 2ml;



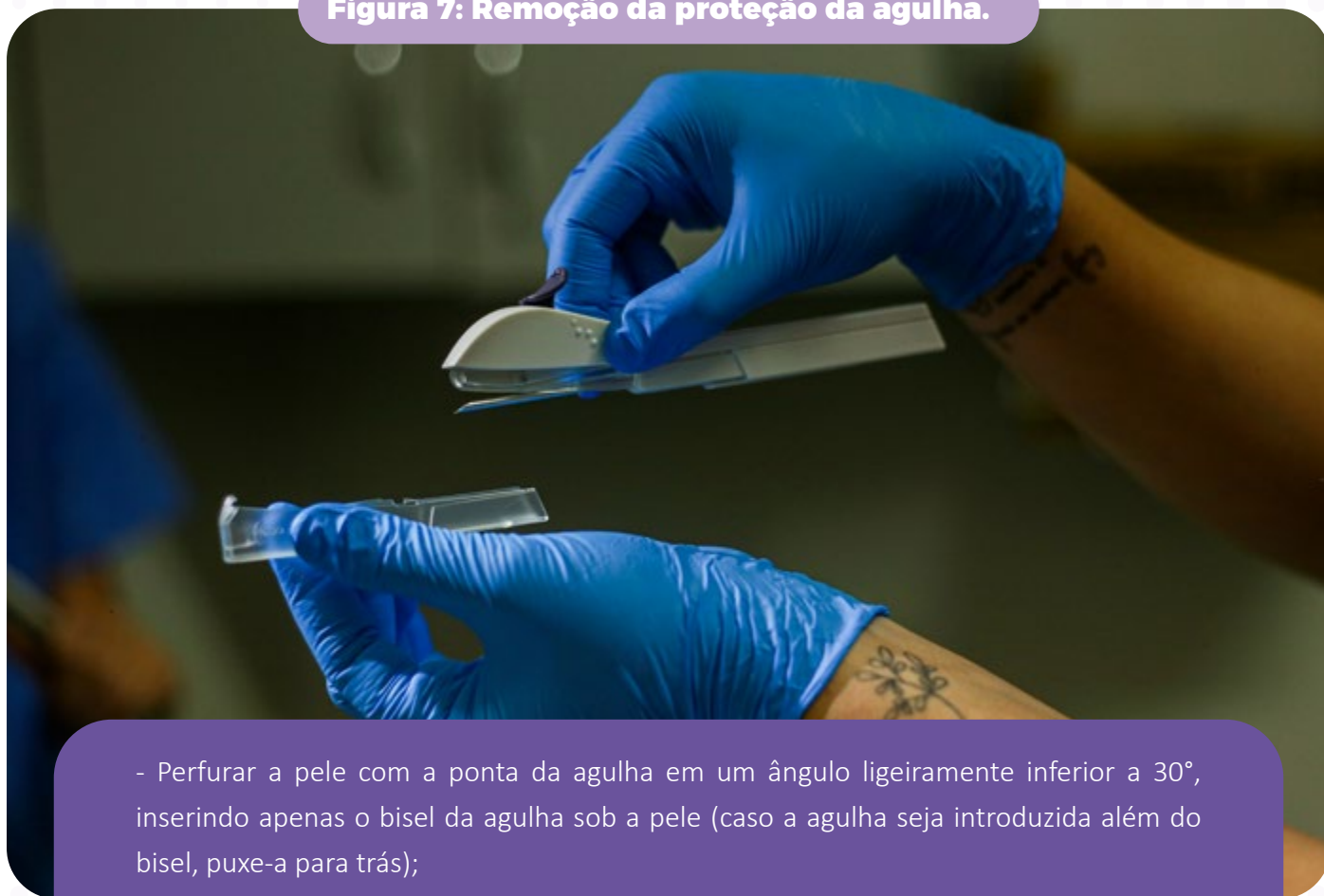
IMPORTANTE: A dose máxima recomendada de lidocaína a 2%, sem vasoconstritor, para infiltração local em adultos é de 4,5 mg/kg por aplicação, não ultrapassando o limite total de 300 mg.



Figura 6: Anestesia do local de inserção.

- Retirar o aplicador do blíster, mantendo a agulha e o implante estéreis. Em caso de contaminação, outro implante deve ser utilizado;
- Retirar a proteção da agulha, segurando na lateral do aplicador;
- Esticar a pele em direção ao cotovelo e inserir o implante de maneira subdérmica, logo abaixo da pele;

Figura 7: Remoção da proteção da agulha.



- Perfurar a pele com a ponta da agulha em um ângulo ligeiramente inferior a 30°, inserindo apenas o bisel da agulha sob a pele (caso a agulha seja introduzida além do bisel, puxe-a para trás);
- Abaixar o aplicador para posição paralela à superfície da pele;
- Esticar a pele em direção ao cotovelo e inserir o implante de maneira subdérmica, logo abaixo da pele;

Figuras 7 e 8: Introdução da agulha na pele.

- Tracionar a pele e empurrar a agulha cuidadosamente até que esteja completamente subdérmica. Ainda que sinta resistência, não exercer força excessiva. Caso a ponta da agulha perfure a pele, o aplicador deve ser puxado para trás e recolocado na posição subdérmica correta;
- Puxar a alavanca roxa somente após a inserção total da agulha, sem mover a agulha ou o aplicador;

**Figura 9: Disparo da alavanca roxa.**

- Confirmar a presença do implante no braço por palpação imediatamente após a inserção. Solicitar que a pessoa também realize a palpação, protegendo o orifício de entrada. Ao palpar ambas as extremidades do implante, deve ser possível confirmar a presença do bastão de 4 cm;
- Realizar o curativo no local utilizando uma gaze estéril com um curativo compressivo; a fim de minimizar hematomas. Orientar que o curativo pode ser substituído por outro curativo menor após 24 horas, devendo ser mantido por 3 a 5 dias





Figura 10: Curativo compressivo.

Observações:

- Durante todo o procedimento de inserção, o profissional deve conseguir ver a agulha logo abaixo da pele;
- Se a agulha não tiver sido totalmente inserida ou se o aplicador for movimentado quando a alavanca roxa for acionada, uma parte do implante pode ficar exteriorizada, caso isso aconteça, não empurre o implante, remova e descarte esse implante.

7.1 - Procedimentos pós inserção

- Orientar que a usuária evite atividades traumáticas ou com peso no membro durante 24 horas; e que é possível o aparecimento de equimose local após o procedimento;
- Manter o curativo seco; para o banho, proteger o local com filme PVC;
- Orientar uso de preservativo para todas as pessoas e reforçar que o implante não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);
- Orientar prática sexual protegida durante os 7 (sete) dias após a inserção para os casos em que a inserção ocorreu após o 7º dia do ciclo menstrual;
- Informar que hematomas locais costumam ter resolução espontânea em 7(sete)a 14 (quatorze dias), podendo ser usada compressa fria no local para alívio.

8. REGISTRO DO PROCEDIMENTO

Após finalizar o procedimento, o profissional deve registrar o procedimento no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) ou em prontuário institucional padronizado na unidade de saúde, informando o braço onde foi realizada a inserção ou retirada do implante, bem como os dados de lote e validade do implante inserido.

O profissional deve entregar à usuária o cartão contendo: a data da inserção, a data limite prevista para a remoção do implante, número do lote e a identificação do braço onde foi realizada a inserção, devidamente assinado e carimbado pelo(a) profissional responsável pelo procedimento. A etiqueta do dispositivo, com o número do lote, deve ser colada no termo assinado pela paciente e arquivada na unidade de saúde.

Deve haver também o registro adequado do CID: Z300 (aconselhamento geral sobre contracepção), Z308 (outro procedimento anticoncepcional), Z309 (procedimento anticoncepcional não especificado) e/ou CIAP W14 (Contracepção/outros); e os códigos SIGTAP: 03.01.04.017-6 - inserção do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel; ou 03.01.04.018-4 – retirada do implante subdérmico liberador de etonogestrel.

Este passo a passo demonstra, de forma simples e ilustrada, como registrar no PEC/e-SUS APS a inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel.

Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 CPF: 101836517260002 Nome da mãe: Maria de Lurdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas
Lista de problemas/condições
Medições
Medicamentos em uso
Problemas/condições autorreferidas
Lembretes
Resultados de exames

Antecedentes

S Subjetivo

Usuária G6F0, 25a, participou previamente de atividade de educação em saúde sobre planejamento reprodutivo, com orientação e aconselhamento para escolha do método contraceptivo. Optou pelo uso de implante subdérmico de longa duração. Compete para inserção do método. Refere desejo de contracepção segura, reversível e de longa duração. Negar alergias conhecidas. Refere conhecimento sobre possíveis efeitos adversos (irregularidade menstrual, cefaleia, sensibilidade mamária). História prévia de uso de anticoncepcional oral, com queixa de esquecimento frequente. Última menstruação há 10 dias, sem relações desprotegidas desde então.

Motivo da consulta (CIAP 2)

CONTRACEPÇÃO/OUTROS - W14



Motivo da consulta (CIAP 2)

CONTRACEPÇÃO/OUTROS - W14

O Objetivo

SSVV dentro da normalidade.
Exame físico sem alterações significativas.
TR gestação: negativo.
Procedimento de inserção de implante contraceptivo realizado em braço não dominante (E), face interna, a 8-10 cm do epicôndilo medial, em pele íntegra, sem sinais de infecção, lesão ou cicatrizes.

Realizada técnica asséptica:

- Antissepsia local com clorexidina alcoólica;
- Anestesia infiltrativa com lidocaína 2% sem vasoconstritor;
- Inserção do implante subdérmico com técnica adequada;
- Palpação pós-inserção confirmou posicionamento correto.

Realizado curativo estéril, sem sangramento ativo.

DUM ⓘ

15/09/2025



Última DUM:

Não registrada

▼ Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar

▼ Marcadores de consumo alimentar

Vacinação em dia?



Sim



Não

Resultados de exames

+ Adicionar resultados de exames

🔍 Histórico de resultados de exames

A

Avaliação

**B** *I* U 

Usuária, cliente e informada após aconselhamento sobre opção de método. Não apresenta nenhuma contraindicação ao implante.

Implante subdérmico contraceptivo inserido com sucesso, sem intercorrências imediatas. Usuária orientada quanto aos cuidados locais, sinais de complicação e retorno em caso de dor, calor, edema, sangramento ou dificuldade em palpar o implante.



365/4000 caracteres

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento *

Preenchimento obrigatório.

Pesquisar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão



CIAP 2

CONTRACEPÇÃO/OUTROS - W14



Incluir na lista de problemas/condições

Adicionar

▼ Alergias e reações adversas

P Plano

☐ Cidadão em observação ⓘ

B I U S "

- Manter curativo por 24h.
- Evitar molhar o local por 24h e não realizar esforço físico intenso com o braço por 48h.
- Orientada sobre possíveis efeitos colaterais e benefícios do método.
- Agendada reavaliação em 30 dias, e oriento antes caso necessário.
- Registro (4s58465) lote, (09/2028) validade e local de inserção do implante em prontuário (braço esquerdo) e em cartão da usuária.

395/4000 caracteres



Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 | CPF — CNS 101836537260002 | Nome da mãe: Maria de Lourdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Resultados de exames

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

teste de gravidez

Teste rápido de gravidez
Código 0214010066

Prescrição de medicamentos

+ Adicionar prescrição

Pesquisar por medicamento Ver apenas as prescrições que possuem medicamento de uso contínuo

Nenhuma prescrição realizada

Compartilhamento de cuidado



Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 | CPF — CNS 101836537260002 | Nome da mãe: Maria de Lourdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Resultados de exames

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

inserção do implante subdérmico

Inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel
Código 0301040176

Prescrição de medicamentos

+ Adicionar prescrição

Compartilhamento de cuidado

442/6000 caracteres

Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 | CPF - CNS 101836517260002 | Nome da mãe: Maria de Lurdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Resultados de exames

Encaminhar para acompanhamento regular em consulta de planejamento reprodutivo.
Registro do lote (A458445), validade (09/2028) e local de inserção do implante em prontuário e em cartão de usuário. 442/1000 caracteres

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados
CIAP 2

SIGTAP
Retirada do implante
Retirada do implante subdérmico liberador de etonogestrel
Código 0301040584

Prescrição de medicamentos
+ Adicionar prescrição

Pesquisar por medicamento Ver apenas as prescrições que possuem medicamento de uso contínuo
Nenhuma prescrição realizada

Compartilhamento de cuidado



Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 | CPF - CNS 101836517260002 | Nome da mãe: Maria de Lurdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Resultados de exames

Encaminhar para acompanhamento regular em consulta de planejamento reprodutivo.
Registro do lote (A458445), validade (09/2028) e local de inserção do implante em prontuário e em cartão de usuário. 442/1000 caracteres

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados
CIAP 2

SIGTAP
curativo simples
Curativo simples
Código 030100104

Prescrição de medicamentos
+ Adicionar prescrição

Pesquisar por medicamento Ver apenas as prescrições que possuem medicamento de uso contínuo
Nenhuma prescrição realizada

Compartilhamento de cuidado



Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 | CPF - CNS 101836517260002 | Nome da mãe: Maria de Lurdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Resultados de exames

Prescrição de medicamentos
+ Adicionar prescrição

Prescrição de medicamentos Solicitação de exames/procedimentos Atestados Orientações Encaminhamentos Compartilhamento de cuidado

Prescrição de medicamentos
+ Adicionar prescrição

Presquisar por medicamento Ver apenas as prescrições que possuem medicamento de uso contínuo
Nenhuma prescrição realizada

Finalização do atendimento

Tipo de atendimento *
☒ Consulta no dia ☐ Urgência

☒ Cidadão participou do atendimento

Forma de participação
Presencial

Ana Maria Souza | Sexo Feminino
25 anos e 8 meses | Nasceu em 02/02/2000 | CPF — CNS 101836517260002 | Nome da mãe: Maria de Lurdes Souza

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos SDC

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Resultados de exames

Ficha de notificação de caso suspeito Imprimir

Racionalidade em saúde (Exceto alopatia/convencional)

Conduta *

☒ Retorno para consulta agendada ☐ Retorno para consulta programada / cuidado continuado

☐ Agendamento para eMulti ☐ Alta do episódio

☐ Agendamento para grupos

Desfecho do atendimento *

☒ Liberar cidadão

☐ Manter cidadão na lista de atendimentos

Agendar consulta

Resumo salvo automaticamente às 13:22 ☐ Imprimir atendimento ao finalizar Cancelar atendimento individual Finalizar atendimento individual

9. RETORNOS CLÍNICOS

O acompanhamento da pessoa com implante deve contemplar não apenas a avaliação da adaptação ao método e manejo de possíveis efeitos indesejados. O momento da consulta de inserção ou seguimento também são oportunidades para realização dos testes rápidos para IST, adequação do rastreamento de neoplasias de colo de útero e mama, além do acompanhamento de comorbidades previamente diagnosticadas. O cuidado integral e longitudinal é fundamental para promover a adesão e prevenir a retirada precoce do implante.

Os sintomas negativos mais comuns são: cefaleia, acne, mastalgia e sangramento desfavorável. Em geral, a cefaléia e a mastalgia são sintomas autolimitados, e a usuária deve ser orientada quanto ao uso de analgésicos simples e à expectativa de resolução espontânea ao longo do tempo.

9.1 - Manejo de intercorrências

9.1.1 - Cistos foliculares

É possível que o implante estimule o surgimento de cistos ovarianos benignos, com ocorrência entre 20 a 25% das usuárias. Na grande maioria dos casos não há manifestação de sintomas, nem necessidade de cirurgia, visto que apresentam regressão espontânea em 8 a 12 semanas (D'ARPE 2016; RICE et al, 1999;

CROXATTO et al, 1998; RATSULA et al, 1989).

A ecografia transvaginal ou pélvica pode ser solicitada para seguimento dos cistos ovarianos quando há sintomatologia associada (dor pélvica persistente, por exemplo); e na ocorrência de sangramento irregular quando o manejo medicamentoso não for satisfatório.

9.1.2 - Acne

A incidência de acne em vigência de uso do implante pode chegar a 11% (BLUMENTHAL et al, 2008), visto que o etonogestrel apresenta efeito androgênico leve. Mediante diagnóstico de acne, é possível utilizar terapia tópica (peróxido de benzoíla, ácido azelaico), antibiótico sistêmico, pílula combinada, espironolactona e isotretinoína, esta última reservada para casos graves ou de difícil controle (SMITH et al, 2025; REYNOLDS et al, 2024; CARMINA et al, 2022; MAVRANEZOULI et al, 2022).

Considerando o perfil de segurança da espironolactona e sua disponibilidade por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, pode ser utilizada como medicação oral de primeira escolha. Recomenda-se que seja iniciada na dose de 50mg a 100mg ao dia, e mantida por 3 a 6 meses, reavaliando a continuidade e ajuste de dose da medicação após esse período. Ocorre melhora significativa do quadro em mais de 60% das usuárias nesse intervalo (SMITH et al, 2025; VIEIRA, 2024).

9.1.3 - Sangramento desfavorável

Para facilitar a abordagem, o padrão de sangramento dos contraceptivos de progestagênio isolado foi classificado em favorável ou desejável, e desfavorável ou indesejável. Esta classificação decorre das taxas de descontinuidade do implante de acordo com o padrão de sangramento apresentado (MANSOUR et al, 2008).

Entre as usuárias desse método, 78% apresentam padrão de sangramento favorável:

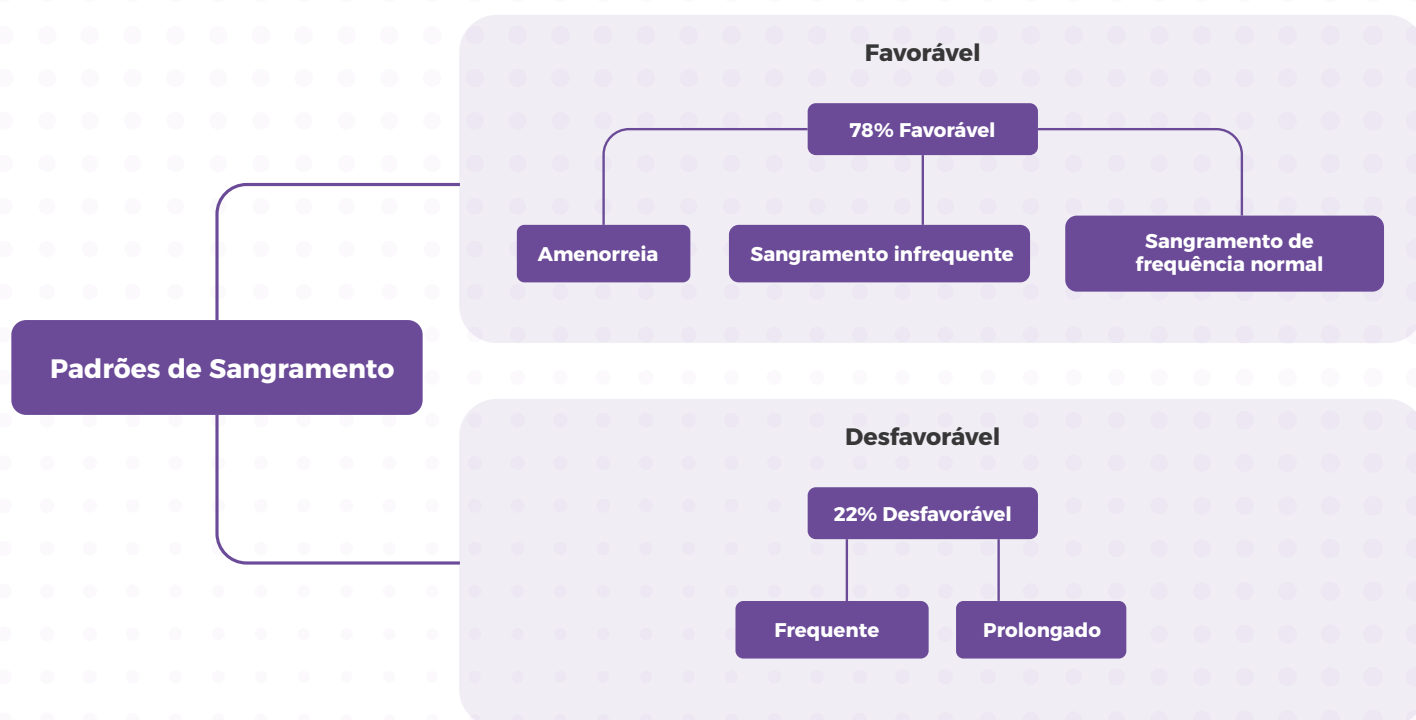
- Amenorreia;
- Sangramento infrequente ou normal (sangramento menos de uma vez por mês);
- Sangramento de frequência normal (sangramento uma vez por mês).

Enquanto 22% apresentam padrão desfavorável (prolongado ou frequente) aos 12 meses de uso do implante:

- Frequente (sangra mais que uma vez por mês);
- Prolongado (independente da frequência, quando ocorre, dura 14 ou mais dias por mês).

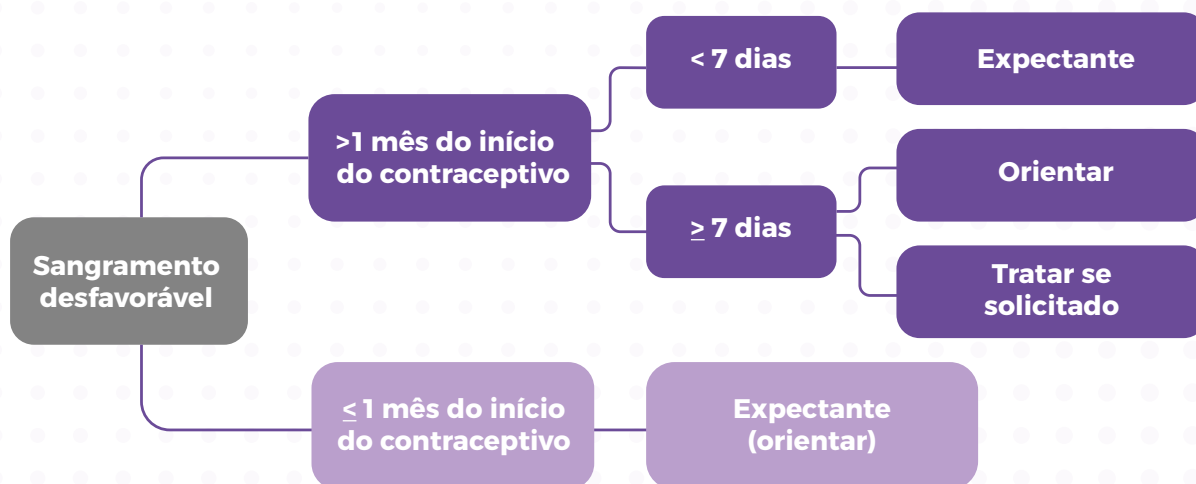
A frequência de sangramento desfavorável é maior nos primeiros 3 meses (40-50%), reduzindo ao longo do primeiro ano de uso do implante. Usuárias com padrão de sangramento favorável nos primeiros três meses de uso do implante, tendem a manter este padrão nos próximos dois anos do implante. Já pacientes com padrão desfavorável, apresentam 50% de chance de melhora deste padrão especialmente no primeiro ano de uso do implante (MANSOUR et al, 2008).

Fluxograma 1: Padrões de sangramento.



Mansour, 2008.

Deve-se realizar o aconselhamento sobre o sangramento conforme proposto no fluxograma abaixo:



Mansour, 2008.

Mediante indicação de tratamento e abordagem medicamentosa do sangramento desfavorável, podem ser utilizadas as medicações descritas na Tabela 2. Como não se sabe a causa do sangramento desfavorável, os medicamentos existentes interrompem o sangramento vigente, mas não evitam a recidiva do sangramento. Assim, o tratamento serve para garantir conforto durante o período de adaptação ao método ou para interromper episódios de sangramento prolongado em pacientes já adaptadas ao método.

Deve-se usar uma terapêutica de cada vez, avaliando a usuária após cada prescrição. Utilizar todos os fármacos propostos de uma só vez é uma prática desencorajada e equivocada.

Caso haja recorrência do sangramento desfavorável na mesma usuária, deve-se utilizar como primeira linha o medicamento que a fez ter melhora clínica previamente (GUAZELLI et al, 2022).

Tabela 2: Medicações que podem ser utilizadas em sangramento desfavorável em usuárias de implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel.

DROGA	POSOLOGIA
Ácido tranexâmico 500mg (1) ou ibuprofeno 600mg	1 comprimido a cada 8 horas por 5 dias
Pílula combinada: Etinilestradiol 30 mcg + Levonorgestrel 150 mcg	1 comprimido ao dia por 2 a 4 semanas
Doxiciclina 100mg	1 comprimido a cada 12 horas por 5 dias
Injetável mensal: 25 mg de acetato de medroxiprogesterona + 5 mg de cipionato de estradiol	1 ampola IM em dose única

De acordo com as orientações da Febrasgo (2022), outras medicações não padronizadas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), também são alternativas seguras e recomendadas para o manejo do sangramento desfavorável, como a Noretisterona 10 mg (01 comprimido ao dia, por 07, 14 ou 30 dias), Ácido Mefenâmico 500mg (01 comprimido a cada 08 horas por 05 dias), Tamoxifeno 10mg (01 comprimido a cada 12 horas por 07 dias) e o Desogestrel 75mcg (01 comprimido ao dia por 30 a 90 dias).

Andrade et al, 2025; Sinthuchai et al, 2024; Guazelli et al, 2022; Zigler, 2017; Mansour et al, 2011.

1. Medicação avaliada para o implante de levonorgestrel.

2. Este foi o anti-inflamatório testado no implante de etonogestrel, mas pode-se utilizar qualquer anti-inflamatório por 5 dias, inclusive o ibuprofeno 600mg disponível na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

9.1.4 - Gravidez em uso do dispositivo

Ainda que apresente alta taxa de eficácia, não se exclui completamente o risco de gravidez, especialmente caso a avaliação prévia à inserção seja realizada de forma equivocada. Neste caso o implante deve ser retirado quanto antes por profissional habilitado.

Importante que a usuária seja orientada que o etonogestrel não é abortivo e nem é uma medicação teratogênica, ou seja, não causa malformações no feto caso ocorra gravidez inadvertida durante o uso do método (LAZORWITZ et al, 2018).

9.1.5 - Fratura do implante

Implantes que, por alguma razão, apresentem fissuras ou quebras – como em casos de impactos causados por esportes de contato ou acidentes – pode haver mudança do padrão de liberação do etonogestrel, bem como alteração do padrão de sangramento (CAMPODONICO, 2019). Dessa forma, é recomendado que se discuta com a usuária sobre a manutenção ou troca do dispositivo.

9.1.6 - Infecção local após inserção

Deve-se suspeitar de infecção quando houver sinais flogísticos, como eritema, calor local, dor e secreção purulenta no sítio da implantação. Orientar medidas de higiene local e avaliar a necessidade de antibioticoterapia para infecções de pele. Manter seguimento próximo e reavaliações constantes, atentando para sinais que podem indicar necessidade de drenagem. Caso apresente sintomas sistêmicos ou ausência de resposta ou recidiva de infecção, proceder à retirada do dispositivo e inserção no braço contralateral.

10. RETIRADA DO IMPLANTE

O implante deve ser retirado após três anos de uso do método ou a qualquer momento em que a usuária apresente esse desejo, ainda que anterior ao limite da duração. Diante de sintomas negativos passíveis de manejo, informar à pessoa as possibilidades de tratamento e deixar que ela decida de maneira consciente e informada sobre a continuidade ou não do método.

Caso o implante não esteja palpável logo abaixo da pele, é necessária a realização de exame de imagem para identificar a localização correta. Tendo em vista que o implante é radiopaco, a radiografia simples é a primeira escolha para essa avaliação. No caso de implantes com fissuras ou quebras, deve-se atentar para quais partes do implante são palpáveis e, se necessário, realizar mais de uma incisão para retirada completa. A abordagem de retirada dos implantes profundos deve ser realizada em serviços da Atenção Especializada, onde estão disponíveis especialistas em cirurgia geral e/ou cirurgia vascular.

Para a **retirada de implantes palpáveis**, os seguintes materiais são necessários:

- Luvas de procedimento ou estéreis;
- Antisséptico (clorexidina alcoólica 0,5%, álcool 70% ou iodopovidona tópico 10%);
- Gaze estéril;
- Seringa de 3ml;
- Agulha para aspiração 40x12mm;
- Agulha para injeção 13x4.5mm;
- Lidocaína 1% ou 2%, sem vasoconstritor;
- Pinça Halstead (Mosquito) ou Pinça Kelly
- Lâmina de bisturi N.º 15 ou 11, preferencialmente;
- Esparadrapo e/ou atadura.

O uso de material de sutura, como porta-agulha e fio de nylon 4.0, é opcional e indicado apenas quando houver necessidade de fechamento do ponto de inserção após a remoção do implante.

Após conferência do material, explique à pessoa cada etapa do procedimento e esclareça suas dúvidas, garantindo a compreensão e consentimento informado antes do início da retirada.

Antes de iniciar, o implante deve ser localizado por palpação e ter sua extremidade proximal (em direção ao ombro) comprimida para que uma saliência fique visível na pele, indicando a extremidade distal (mais próxima ao cotovelo).

O profissional deve cumprir a seguinte sequência para remoção do implante:

- Lavar as mãos;
- Limpar a extremidade distal identificada e realizar antisepsia local;
- Realizar anestesia com 0.5 a 1 ml de lidocaína 1% ou 2%, sem vasoconstritor no local, no local escolhido para fazer a incisão. Certificar-se de injetar o anestésico abaixo do implante, de modo a mantê-lo próximo à superfície da pele.



Figura 12: Anestesia para retirada.

Empurrar a extremidade proximal do implante para estabilizá-lo e realizar uma incisão longitudinal de 2 mm em direção ao cotovelo, a partir da ponta distal do implante, tendo cuidado para não seccionar sua ponta



Figura 13: Incisão para retirada.

Empurrar suavemente o implante em direção à incisão até que a extremidade seja visível. Segure o implante com uma pinça, de preferência do tipo Halstead “mosquito” curva ou reta, e proceda à sua remoção;

Figura 14, 15 e 16: Tração do implante.



- Se houver fibrose, remover o tecido por dissecção romba. Caso a extremidade do implante ainda não se exteriorize, realize uma incisão com bisturi na cápsula e então remova o implante com uma pinça do tipo Halstead “mosquito” curva ou reta;
- A depender do tamanho da incisão, realizar sutura simples no local e orientar a usuária quanto à retirada dos pontos em 7 a 10 dias;
- Realizar um curativo estéril para fechamento de ferida, e aplicar uma gaze estéril com uma faixa compressiva para minimizar a formação de equimose;
- Orientar a usuária que ela poderá remover a faixa em 4 a 6 horas e o curativo de fechamento de ferida após 3 a 5 dias.

11. TROCA DO IMPLANTE

O novo implante pode ser inserido no mesmo braço e, frequentemente, através da mesma incisão por onde o implante anterior foi retirado. Caso a mesma incisão seja usada para inserir um novo implante, as instruções a seguir também devem ser levadas em consideração:

- Anestesiocar o local da inserção com 2 mL de lidocaína (1%), aplicada logo abaixo da pele, iniciando no local da incisão de retirada ao longo do trajeto de inserção;
- Durante a substituição, a inserção completa da agulha também é muito importante. Caso esse procedimento não seja seguido corretamente, o implante ficará parcialmente visível na incisão de retirada na pele;
- Fechar a incisão com um curativo, de modo a aproximar as bordas da incisão;
- Aplicar curativo com gaze estéril para evitar lesões. Manter o curativo no local por pelo menos 24 horas para permitir a cicatrização da incisão da retirada

Quando o local de inserção anterior não for apropriado, é possível realizar a inserção do novo implante no braço contralateral, respeitando as mesmas técnicas de inserção utilizadas inicialmente. A usuária deve seguir as mesmas orientações descritas no item 7.1 (Procedimentos pós inserção).

**Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para implante
subdérmico liberador de etonogestrel 68 mg**

Nome da(o) paciente: _____

Nome da(o) responsável legal (sem obrigatoriedade): _____

_____, Eu, _____ (nome),
CPF _____, declaro ter recebido informações a respeito de benefícios, riscos,
contraindicações e principais efeitos colaterais relacionados ao uso de implante subdérmico contraceptivo
liberador de etonogestrel, indicado como método contraceptivo reversível de longa ação.

Compreendo que o implante contraceptivo é um pequeno tubo de plástico, de cerca de 4 centímetros
de comprimento por 2 milímetros de largura contendo um progestagênio (hormônio), chamado
etonogestrel e é colocado debaixo da pele do braço que você não escreve (braço não dominante). Quem
realiza a colocação é um(a) médico(a) ou enfermeiro(a) treinado(a) e habilitado(a) para tanto.

A ação do implante é contínua por 3 anos e acontece com a liberação do hormônio etonogestrel
para o sangue da mulher, e funciona principalmente de dois modos: impede a ovulação e espessa o muco
do colo do útero, o que dificulta a passagem dos espermatozoides para o útero.

O implante tem eficácia superior a 99%, igual ou superior à eficácia da laqueadura tubária (5
gravidezes em 10.000 mulheres que usam o implante). Compreendi ainda que as principais vantagens do
implante são:

- É um método prático e de longa duração (3 anos).
- Evita ter que tomar a pílula todos os dias.
- Não interfere com a relação sexual.
- Não interfere com a amamentação.
- Melhora as cólicas menstruais.
- Pode ser usado pelas mulheres que não podem tomar pílulas contendo estrogênio.
- Não diminui a massa óssea (osteoporose).

Também foram a mim apresentadas as desvantagens desse método:

- Irregularidades da menstruação. Na maioria dos casos, há sangramento irregular, podendo haver
aumento do fluxo menstrual ou ausência de menstruação. Essas alterações são mais comuns no primeiro
ano, sendo que a cada 100 mulheres, 15 podem ter sangramento mais frequente.

- Podem ocorrer algumas alterações da pele, dores de cabeça, enjoos, aumento da sensibilidade mamária
e variações do humor (semelhantes às que ocorrem com outros métodos contraceptivos como a pílula).

- Podem aparecer cistos benignos nos ovários, que geralmente não necessitam de tratamento.

Foi informado a mim também que o implante pode ser colocado até 5 dias após o início
da sua menstruação (para garantir que não há gravidez). Nas puérperas (mulheres que tiveram

parto recente), pode ser colocado imediatamente após o parto a depender do desejo da mulher.

É eficaz em até sete dias após a colocação. É colocado na parte interna do braço, debaixo da pele, como se fosse uma injeção. É necessária anestesia no local para inserção do implante. Pode ocorrer alguma dor, algum inchaço ou hematoma pequeno no local da colocação, mas passa rapidamente. É removido 3 anos após a sua inserção, ou antes, se a seu pedido. Para a remoção do implante, também é preciso ser aplicada a anestesia.

Os termos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo profissional da saúde _____ (nome do profissional da saúde que prescreve), _____ (número de registro no conselho de classe/UF), e sua equipe.

Afirmo ter recebido informação quanto aos efeitos adversos e riscos de uso deste produto, sua frequência e gravidade, explicado de maneira que pude entender. Estou ciente que a expulsão ou migração do implante é possível e que pode ser necessária pequena intervenção cirúrgica para a sua retirada, em casos raros. Declaro, ter recebido orientação da necessidade de acompanhamento após a implantação do dispositivo, inclusive com local e data do retorno.

Recebi informações, inclusive por escrito, de qual lugar devo procurar caso eu tenha alguma complicação.

Assim, estando todas as explicações acima completamente entendidas, como também, depois que tive todas as minhas dúvidas respondidas, declaro satisfação com as informações e que compreendo os benefícios, os riscos e as consequências inerentes ao procedimento de inserção de implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, concordando com as condutas necessárias a realização deste procedimento.

Assim, autorizo o estabelecimento de Saúde _____ (nome do estabelecimento), localizado no endereço, _____ município/UF de: _____ a fazer uso de informações relativas ao meu prontuário que conste informações sobre o uso do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, desde que seja assegurado o anonimato.

Local e data: _____, ____/____/____

Assinatura - Paciente (ou responsável legal)

Assinatura - Profissional de Saúde e registro de conselho de classe

Observação: Este Termo é obrigatório ao se aplicar o implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel 68 mg no serviço autorizado acima e deverá ser preenchido por meio eletrônico, ou impresso em no mínimo duas vias: uma será arquivada no serviço autorizado e prontuário do paciente; e a outra entregue à(ao) paciente ou a(ao) sua(seu) responsável legal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHMAN, E.; SHAH, I. H. New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, v. 115, n. 2, p. 121-126, 2011. DOI: 10.1016/j.ijgo.2011.05.027.

Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2011.05.027>. Acesso em: 11 nov. 2024.

ANDRADE, M. C. R. et al. Norethisterone for Prolonged Uterine Bleeding Associated with Etonogestrel Implant (IMPLANET): A Randomized Controlled Trial. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 2025.

BAHAMONDES, L. et al. A 3-year multicentre randomized controlled trial of etonogestrel- and levonorgestrel-releasing contraceptive implants, with non-randomized matched copper-intrauterine device controls. *Human Reproduction*, v. 30, n. 11, p. 2527-38, nov. 2015. DOI: 10.1093/humrep/dev221.

BLUMENTHAL, P. D. et al. Tolerability and clinical safety of Implanon. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, v. 13, suppl. 1, p. 29-36, 2008. DOI: 10.1080/13625180801960012.

BRAGA, G. C. et al. Immediate postpartum initiation of etonogestrel-releasing implant: A randomized controlled trial on breastfeeding impact. *Contraception*, v. 92, n. 6, p. 536-42, dez. 2015.

BRAGA, G. C. et al. Menstrual management using the etonogestrel implant in individuals with intellectual disabilities in Joinville, Brazil. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, v. 168, n. 3, p. 1244-1250, mar. 2025. DOI: 10.1002/ijgo.15930.

BRASIL. Lei Nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Seção 1, p. 13563.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta Nº. 2/2022. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação-Geral de Ciclos da Vida. Coordenação de Saúde dos Adolescentes e Jovens. Atualização das recomendações aos profissionais de saúde para o atendimento de adolescentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-2-2022.pdf/@download/file>. Acesso em 11 de ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26). Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.

BRITO, M. B. et al. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. *Contraception*, v. 80, n. 6, p. 519-26, dez. 2009.

CAMPODONICO, J. et al. Reports of Two Broken Nexplanon® Rods. *Journal of the American Board of Family Medicine*, v. 32, n. 2, p. 269-271, 2019. DOI: 10.3122/jabfm.2019.02.180222.

CARMINA, E. et al. Female Adult Acne and Androgen Excess: A Report From the Multidisciplinary Androgen Excess and PCOS Committee. *Journal of the Endocrine Society*, v. 6, n. 3, fev. 2022. DOI: bvac003.

CARMO, L. S. M. P. et al. Timing of Etonogestrel-Releasing Implants and Growth of Breastfed Infants: A Randomized Controlled Trial. *Obstetrics & Gynecology*, v. 130, n. 1, p. 100-107, jul. 2017.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Parecer nº 277, de 06 de dezembro de 2017. Solicitação de orientação sobre inserção de implante subdérmico. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/parecer-no-277-2017-cofen-ctasc/>. Acesso em: 11 nov. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-2024/>. Acesso em: 11 nov. 2024.

CREININ, M. D. et al. Recommendations for standardization of bleeding data analyses in contraceptive studies. *Contraception*, v. 112, p. 14-22, ago. 2022. DOI: 10.1016/j.contraception.2022.05.011.

CROXATTO, H. B.; MÄKÄRÄINEN, L. RETRACTED: The pharmacodynamics and efficacy of Implanon. An overview of the data. *Contraception*, v. 58, n. 6 Suppl, p. 91S–97S, 1998. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0010-7824\(98\)00118-8](https://doi.org/10.1016/s0010-7824(98)00118-8). (Retraction published *Contraception*. 2004 Nov;70(5):433. doi: 10.1016/j.contraception.2004.07.004. *Contraception*. 2025 Aug;148:110950. doi: 10.1016/j.contraception.2025.110950.).

D'ARPE, S. et al. Ovarian function during hormonal contraception assessed by endocrine and sonographic markers: a systematic review. *Reproductive Biomedicine Online*, v. 33, n. 4, p. 436-448, 2016.

DARNEY, P. et al. Safety and efficacy of a single-rod etonogestrel implant (Implanon): results from 11 international clinical trials. *Fertility and Sterility*, v. 91, n. 5, p. 1646-53, maio 2009.

DARROCH, J. E.; SULLY, E.; BIDDLECOM, A. Adding It Up: Investing in Contraception and Maternal and Newborn Health. New York: Guttmacher Institute, 2017. Disponível em: <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-up-contraception-mnh-2017>. Acesso em: 11 nov. 2024.

DE NADAI, M. N. et al. Effects of the immediate postpartum insertion of the etonogestrel implant on the development of breastfed infants: Results from a randomized controlled trial. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 9 jun. 2025. DOI: 10.1002/ijgo.70291.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Postagens: Principais Questões sobre Mortalidade Materna e Acesso ao Planejamento Reprodutivo. Rio de Janeiro, 24 jul. 2024. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/principais-questoes-sobre-mortalidade-materna-e-acesso-ao-planejamento-reprodutivo/>. Acesso em: 11 nov. 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Fiocruz). Especial sobre Pesquisa Nascer no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 30, supl. 1, 2014. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/cadernos-de-saude-publica-lancaespecial-sobre-pesquisa-nascer-no-brasil>. Acesso em: 26 dez 2024.

GLASIER, A. Implantable contraceptives for women: effectiveness, discontinuation rates, return of fertility, and outcome of pregnancies. *Contraception*, v. 65, n. 1, p. 29-37, 2002.

GUAZZELLI, C. A. et al. Manejo do sangramento irregular com os contraceptivos reversíveis de longa ação. In: FEBRASGO. Sangramento irregular com os LARCs. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de

Ginecologia e Obstetrícia, 2022. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO, n. 2; Comissão Nacional de Anticoncepção).

HARVEY, C.; SEIB, C.; LUCKE, J. Continuation rates and reasons for removal among Implanon® users accessing two family planning clinics in Queensland, Australia. *Contraception*, v. 80, n. 6, p. 527-532, 2009.

LAZORWITZ, A. et al. Ongoing Etonogestrel Contraceptive Implant Use Throughout Pregnancy. *The Journal of Adolescent Health*, v. 63, n. 3, p. 363-364, 2018. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2018.03.021.

MACHADO, R. B. et al. Aspectos atuais dos contraceptivos reversíveis de longa ação. In: FEBRASGO. *Contracepção reversível de longa ação*. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 2022. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO, n. 1; Comissão Nacional de Anticoncepção).

MANSOUR, D. et al. Can initial vaginal bleeding patterns in etonogestrel implant users predict subsequent bleeding in the first 2 years of use? *Contraception*, v. 100, n. 4, p. 264-268, out. 2019. DOI: 10.1016/j.contraception.2019.05.017.

MANSOUR, D. et al. The effects of Implanon on menstrual bleeding patterns. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, v. 13, suppl. 1, p. 13-28, 2008. DOI: 10.1080/13625180801959931. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13625180801959931>.

MANSOUR, D.; BAHAMONDES, L.; CRITCHLEY, H.; DARNEY, P.; FRASER, I. S. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users. *Contraception*, v. 83, n. 3, p. 202-10, mar. 2011. DOI: 10.1016/j.contraception.2010.08.001.

MAVRANEZOULI, I. et al. A systematic review and network meta-analysis of topical pharmacological, oral pharmacological, physical and combined treatments for acne vulgaris. *British Journal of Dermatology*, v. 187, n. 5, p. 639-649, nov. 2022.

MODESTO, W.; BAHAMONDES, M. V.; BAHAMONDES, L. A randomized clinical trial of the effect of intensive versus non-intensive counselling on discontinuation rates due to bleeding disturbances of three long-acting reversible contraceptives. *Human Reproduction*, v. 29, n. 7, p. 1393-1399, 2014.

MORAY, K. V. et al. A systematic review on clinical effectiveness, side-effect profile and meta-analysis on continuation rate of etonogestrel contraceptive implant. *Reproductive Health*, v. 18, n. 1, p. 4, 6 jan. 2021. DOI: 10.1186/s12978-020-01054-y.

RATSULA, K. et al. Plasma levonorgestrel levels and ovarian function during the use of a levonorgestrel-releasing intracervical contraceptive device. *Contraception*, v. 39, n. 2, p. 195-204, 1989. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0010-7824\(89\)80008-3](https://doi.org/10.1016/s0010-7824(89)80008-3).

REED, S. et al. Real world data on Nexplanon® procedure-related events: final results from the Nexplanon Observational Risk Assessment study (NORA). *Contraception*, v. 100, n. 1, p. 31-36, jul. 2019.

REYNOLDS, R. V. et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 30 jan. 2024. DOI: S0190-9622(23)03389-3.

RICE, C. F. et al. A comparison of the inhibition of ovulation achieved by desogestrel 75 micrograms and levonorgestrel 30 micrograms daily. *Human Reproduction*, v. 14, n. 4, p. 982-985, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/humrep/14.4.982>.

SINTHUCHAI, N. et al. Effect of a single dose of a combination injectable contraceptive for treatment of bothersome uterine bleeding in contraceptive implant(s) users: A randomized double-blind placebo-controlled trial. *Contraception*, v. 131, p. 110354, mar. 2024. DOI: 10.1016/j.contraception.2023.110354.

SIUM, A. F. et al. Non-Palpable Contraceptive Implant Evaluation and Removal: A Protocol That Can Be Adopted for Practice in Low-Middle Income Countries. *Public Health Challenges*, v. 4, n. 3, p. e70086, 1 ago. 2025.

SMITH, C. A. et al. Hormonal Therapies for Acne: A Comprehensive Update for Dermatologists. *Dermatology and Therapy*, v. 15, n. 1, p. 45–59, 2025. DOI: 10.1007/s13555-024-01324-8.

TEUNISSEN, A. M.; GRIMM, B.; ROUMEN, F. J. M. E. Continuation rates of the subdermal contraceptive Implanon® and associated influencing factors. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, v. 19, n. 1, p. 15-21, 2014.

TEPPER, N. K.; MARCHBANKS, P. A.; CURTIS, K. M. Use of a checklist to rule out pregnancy: a systematic review. *Contraception*, v. 87, n. 5, p. 661-5, maio 2013.

TRUSSELL, J. Contraceptive failure in the United States. *Contraception*, v. 83, n. 5, p. 397–404, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2011.01.02>.

VIEIRA, C. S. Protocolo de abordagem de acne por uso de contraceptivo de progestagênio isolado do setor de anticoncepção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo. 2024.

VIEIRA, C. S. Protocolo de abordagem de sangramento por uso de contraceptivo de progestagênio isolado do setor de anticoncepção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo. 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services. Guidelines Review Committee, Sexual and Reproductive Health and Research (SRH). 201.

ZIGLER, R. E.; MCNICHOLAS, C. Unscheduled vaginal bleeding with progestin-only contraceptive use. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 216, n. 5, p. 443-450, maio 2017. DOI: 10.1016/j.ajog.2016.12.008.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

